

선택적 함묵증 자가 실행 프로그램 (CBT 기반)

이 자료는 인지행동치료(CBT)의 원리를 바탕으로 한 자가 연습용 안내서입니다. 전문 치료를 대신하지 않습니다. 증상이 심하거나, 학교·직장·일상에 큰 지장이 있거나, 우울·자해 생각이 함께 있다면 정신건강 의학과 또는 임상심리 전문가와 함께 진행하세요. (위기 시: 자살예방상담전화 109, 정신건강위기상담 1577-0199)

함께 제공되는 연습 기록지(worksheets.pdf) 에 직접 적으며 진행하세요. 예시 과제 100개는 기록지 부록에 있습니다.

0. 선택적 함묵증 이해하기 (심리교육)

- 선택적 함묵증은 말할 수 있는 능력이 있는데도 특정 상황(학교, 직장, 낯선 사람 앞 등)에서 불안 때문에 말이 나오지 않는 상태입니다. "고집"이나 "반항"이 아닙니다.
 - 말을 하지 않으면 불안이 즉시 줄어듭니다 → 이 회피가 보상이 되어 다음에도 말하기가 더 어려워집니다.
 - 주변 사람이 대신 말해 주는 것(구조하기)도 같은 고리를 강화합니다.
 - 해결의 핵심은 아주 작은 단계부터 점진적으로 말하기에 노출하고, 불안이 줄어드는 경험을 반복하는 것입니다.
- 상황 → 불안 ↑ → 침묵/회피 → 불안 ↓ (일시적 안도) → "말하면 위험해" 믿음 강화 → 다음엔 더 어려움

1단계. 나의 패턴 파악하기 (1주)

매일 말하기가 어려웠던 순간을 기록합니다.

날짜	장소/상대	요구된 말	불안(0-10)	실제로 한 행동	떠오른 생각	결과
예) 9/26	편의점 점원	"봉투 주세요"	7	고개만 끄덕임	"목소리가 이상하게 들릴 거야"	봉투 못 받음, 안도 + 자책

확인할 것:

- 편하게 말하는 사람/장소(예: 가족, 집)와 전혀 말이 안 나오는 사람/장소
- 불안을 바꾸는 요인: 사람 수, 친숙도, 거리, 목소리 크기, 시선, 대면 vs 전화/문자
- 내가 쓰는 안전행동: 속삭이기, 고개 끄덕이기, 글로 쓰기, 다른 사람이 대신 말하게 하기

2단계. 불안 사다리(노출 위계) 만들기

말하기 상황을 10~15개 정도 적고 예상 불안(SUDS 0-10) 을 매겨 쉬운 것부터 나열합니다. 선택적 함묵증에서는 다음 "말하기 단계" 를 섞어서 사다리를 세분화하면 효과적입니다.

말하기 단계	예시
0. 비언어 소통	손짓, 고개 끄덕임, 가리키기
1. 소리 내기	웃음소리, 헛기침, "음", 박수
2. 녹음/비대면	녹음한 음성 보내기, 음성 메시지, 문자 → 전화
3. 한 단어	"네", "아니요", "감사합니다"
4. 짧은 문장	"이거 주세요", "화장실 어디예요?"
5. 질문하기/대화 시작	먼저 인사하기, 질문하기
6. 대화 이어가기	2~3번 주고받기, 의견 말하기
7. 여러 사람 앞	모임에서 한마디, 발표

조절할 수 있는 변수 (자극 페이딩):

- 사람: 편한 사람 → 조금 아는 사람 → 낯선 사람
- 장소: 집 → 조용한 공공장소 → 붐비는 곳
- 거리/시선: 등 돌리고 → 멀리서 → 마주 보고
- 인원: 1명 → 2~3명 → 여러 명
- 예측 가능성: 대본 있음 → 즉흥

예시 사다리 (성인):

불안	과제
2	혼자 방에서 내 목소리 녹음해 듣기
3	가족 앞에서 녹음한 문장을 소리 내 읽기
4	음성 메시지로 친구에게 "안녕" 보내기
4	자동응답(ARS) 전화에 말로 응답하기
5	편의점에서 "봉투 주세요" 한 단어/짧은 문장
6	카페에서 음료 주문하기
6	가게에 전화해 영업시간 물어보기
7	동료에게 먼저 "안녕하세요" 인사하기
8	회의에서 짧은 의견 한 문장 말하기

불안	과제
9	3~4명 모임에서 대화 이어가기

예시 사다리 (아동, 보호자와 함께): 집에서 부모와 게임하며 말하기 → 선생님이 복도에 있을 때 문 열고 말하기 → 선생님이 점점 가까이 오기 → 선생님에게 한 단어 → 친구 1명 추가 → 교실에서 소그룹 → 대그룹.

3단계. 노출 연습 실행하기 (핵심, 4~12주)

규칙

1. 사다리에서 예상 불안 3~5 정도의 과제부터 시작합니다. 너무 쉬우면 효과가 없고, 너무 어려우면 실패 경험만 남습니다.
2. 같은 과제를 불안이 처음의 절반 이하가 될 때까지 반복(보통 3~5회)한 뒤 다음 단계로 올라갑니다.
3. 주 4~5회, 하루 1~3개 과제를 권장합니다. 짧게 자주 하는 것이 길게 가끔 하는 것보다 효과적입니다.
4. 가능한 한 안전행동(속삭이기, 눈 피하기, 대신 말해주기 등)을 줄입니다.
5. 실패는 없습니다. 말이 안 나왔다면 한 단계 낮추거나 더 작은 조각으로 나누어 다시 시도합니다.

매 연습의 구조

전	중	후
과제 정하기, 예상 불안(0-10), 걱정 되는 예측 쓰기	호흡을 고르고, 짧게라도 소리 내기, 바로 도망치지 않기	실제 불안(0-10), 예측이 맞았는지 확인, 스스로 보상

불안이 올라올 때 쓰는 기술 (회피 수단이 아니라 버티는 도구로)

- 4-7-8 호흡: 4초 들이마시고, 7초 멈추고, 8초 내쉬기 (2~3회)
- 발바닥 감각, 손에 쥔 물건의 감촉에 주의 두기 (그라운딩)
- 첫 소리를 쉽게: "음...", "저기요"처럼 가벼운 소리로 시작하기
- 미리 연습한 대본 카드 사용 → 익숙해지면 대본 없이

4단계. 생각 다루기 (인지 재구성)

말하기 전에 떠오르는 자동적 사고를 적고 검토합니다.

자동적 사고	증거 찬성	증거 반대	더 균형 잡힌 생각
"내 목소리를 들으면 다들 이상하게 쳐다볼 거야"	예전에 한 번 쳐다본 적 있음	대부분은 신경 쓰지 않았음, 적은원은 하루 수백 명과 말함	"잠깐 쳐다볼 수도 있지만 금방 잊는다. 불편해도 견딜 수 있다"

자주 나타나는 생각의 함정:

- 독심술: "저 사람은 날 이상하다고 생각할 거야"
- 파국화: "말을 더듬으면 끝장이야"

- 스포트라이트 효과: "모두가 나만 보고 있어"
- "이제 와서 말하면 다들 놀랄 거야" — 오랫동안 침묵했던 곳에서 특히 강함. → 대응: 처음에는 놀랄 수 있지만 반응은 금방 사라집니다. 새로운 장소/사람에서 먼저 성공 경험을 쌓는 것도 방법입니다.

행동 실험: "목소리를 내면 사람들이 웃을 것이다(확신 80%)" → 실제로 해보고 → 결과 기록 → 확신도 재평가.

5단계. 보상과 자기 강화

- 과제를 시도한 것 자체에 보상합니다(결과가 아닌 노력).
- 작은 보상 목록을 미리 만듭니다: 좋아하는 간식, 영상 한 편, 스티커(아동), 산책 등.
- 자기 칭찬 문장: "불안했지만 해냈다", "한 단어라도 소리를 냈다"

6단계. 보호자·주변 사람을 위한 가이드 (아동/청소년의 경우)

하면 좋은 것

- 말하라고 압박하지 않고, 대답할 기회를 주고 5초 정도 기다리기
- 예/아니요 질문 → 선택형 질문("빨간색? 파란색?") → 열린 질문 순으로
- 말을 했을 때 과도하게 놀라거나 크게 칭찬하지 않고 자연스럽게 반응하고, 나중에 구체적으로 칭찬하기
- 답임/담당 선생님과 사다리를 공유하고 같은 방식으로 도와주기

피할 것

- 대신 대답해 주기(구조하기), "애는 말 안 해요"라고 소개하기
- 말하면 보상 주겠다고 공개적으로 협상하기, 벌주기
- "왜 말을 안 해?"라고 캐묻기

7단계. 유지와 재발 방지

- 사다리 끝까지 오르지 못했어도 꾸준히 연습 중이면 성공입니다.
- 목표 달성 후에도 주 1~2회 유지 연습을 계속합니다.
- 새 학기, 이직, 이사 등 변화 시기에 증상이 잠시 돌아올 수 있습니다 → 1~2단계 낮은 과제로 다시 시작하면 됩니다.
- 나만의 재발 방지 카드: ① 나에게 경고 신호는? (예: 다시 문자로만 연락하기 시작함) ② 그럴 때 할 첫 과제는? ③ 도와줄 사람은?

주간 계획 예시

주차	목표
1	심리교육, 패턴 기록
2	불안 사다리 작성, 쉬운 과제(2~3) 시작
3-4	중간 과제(4~5) 반복, 생각 기록 시작
5-8	과제 난이도 올리기(6~7), 행동 실험
9-12	어려운 과제(8~10), 일상 속 자연스러운 말하기
이후	유지 연습, 재발 방지 계획

전문가 도움이 필요한 신호

- 4~6주 꾸준히 연습해도 사다리의 첫 단계조차 진행되지 않음
- 학교/직장 생활이 불가능할 정도의 지장
- 우울감, 무기력, 자해·자살 생각
- 아동의 경우 말하기 외에도 먹기·화장실 가기 등 기본 활동까지 회피

전문가 치료에서는 CBT(노출, 자극 페이딩, 형성), 가족·학교 연계 개입, 필요시 약물치료(SSRI 등)를 함께 고려할 수 있습니다.